EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 72478
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 16-10-2023

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JORGE PASCUAL TORO TORRES			RUN	: 11.111.309-2
F.Nac	: 16-03-1967	Edad	: 56 AÑOS, 7 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-10-07	Fecha Egreso	: 16-10-2023	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.9-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica resuelta
a. Atelectasia masiva derecha
b. TEP lobar (LII-LSI)
2. SIRS resuelto
3. Tumor pulmonar derecho en estudio
4. Delirium en tratamiento
5. Disfagia moderada FILS 4 DOSS 2
6. Antecedentes: Artritis reumatoide, ACV 2022, Depresión, Discopatía lumbosacra

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino, de 56 años, en estudio de Ca de pulmón, evaluado 12/09/23 de manera ambulatoria donde se solicita estudio inicial. Refiere historia de disnea de esfuerzo de 2 meses de evolución asociado a baja de peso de 3 kg y hemoptisis. TAC tórax evidencia masa parahiliar derecha con atelectasia parcial del lóbulo superior derecho y obstrucción parcial sobre bronquio principal derecho y ramas lobares, adenopatía infracarinal.
Desde el 22/09/23 presenta mayor disnea y dificultad respiratoria, ingresa al SU del Hospital de San Carlos en malas condiciones generales, taquicárdico, normotenso, sat 85% con MAF 100%, sin fiebre. Laboratorio: crea 0.6 / lactato 1.6 / PCR 37.6 / Bun 23 / Na 144 K 4 Cl 107 / Hb 16 Gb 12.400 Plaq 198.000. TAC evidencia colapso completo de pulmón derecho. Dado persistencia de requerimientos altos de oxígeno y se ingresa a UTI para apoyo con CNAF, ingresa normotenso, taquicardico y sat 87% con MAF, se optimiza manejo con volemización, broncodilatación, dexametasona dosis altas y cobertura antibiótica.
Control gasométrico: GSA 19 hrs: ph 7.49 | pco2 24.8 | po2 48.6 | bic 22.4 // GSA 21 hrs: ph 7.46 | pco2 27.9 | po2 66.2 | bic 23. Evoluciona
clínicamente con discreta mejoría, sin taquicardia, pero persiste con requerimientos altos de CNAF 60 lpm/100%
de FiO2, con Fr: 25 a 30 rpm, saturación 85% fluctuante que baja rápidamente al hablar o con el mínimo esfuerzo.
Se decidió manejo avanzado de vía aérea, y se solicitó traslado a HCHM por falta de cupo UCI en San Carlos

Evolucion por sistemas de HCHM
Hemodinamia: Requirió DVA a dosis bajas - moderadas, asociado a sedación mas no a compromiso hemodinámico. Destetado
Ventilatorio: Ingreso con IOT del HSC, permaneció en VMI durante 10 días en este centro (HCHM), extubado el día 04/10 sin mayores incidentes, con weaning consolidado. Se realizó FBC el 25/10 que evidenció obstrucción del 80% del bronquio derecho; asimismo, se tomó citometría de flujo y biopsia de mucosa bronquial en bronquio fuente derecho con 6 muestras para estudio.
Inflamatorio: Completo 7 días de ATB empírico con ceftriaxona. Panel respiratorio ampliado negativo, con HCs del 29/09 hasta la fecha negativos, con EOC no inflamatorio → Durante su estadía nicio SIRS, con PCR de hasta 224, febril con T° hasta 38.4°C, por lo que se tomaron HCs el 01/10, sin poder tomar CSB por presentar secreciones hemáticas y se inició ATB de 2da línea con vancomicina y meropenem (Hoy en su 5° día), con buena respuesta clínica y de laboratorio, pero sin ningún hallazgo de germen Actualmente con PCR a la baja: 22.5 (anterior. 43), pero con varias febrículas de hasta 37.2°, pero sin compromiso hemodinámico → Por lo anterior, mantener ATB y rescatar HCs del 29/09 y del 01/10.
Psicoafectivo: Paciente con mucha labilidad emocional, sumado a contexto delirioso, por lo que se iniciaron antidepresivos y antipsicóticos respectivamente, con buena respuesta.

Llega a nuestro servicio el dia 7/10/2023 en buenas condiciones generales
HD estable
Afebril

Ex Fisico
Perfundido hidratado
Normotenso

Pa 139 / 111 fc 103 rs sat 98 amb
bien perfundido hidratado
rr2t
mp+ asra hasta las bases
abdomen bdi
eeii sin edemas ni signos de tvp.

Durante estancia hospitalaria en buenas condiciones generales, manteniendo terapia respiratoria por Kinesiología además de Fonoaudiología con progresión favorable.
En vista de historial y requerimientos se solicita seguimiento por Hodom.

INDICACIONES AL ALTA

1. OMEPRAZOL 20 MG 1 cada 24 hrs. via ORAL
2. DABIGATRAN ETEXILATO 110 MG 1 cada 12 hrs. via ORAL
3. SERTRALINA 50 MG 1 cada 24 hrs. via ORAL
4. QUETIAPINA 25 MG 1 cada 24 hrs. via ORAL
5. CARVEDILOL 6,25 MG 1 cada 12 hrs. via ORAL
6. PARACETAMOL 500 MG 2 cada 8 hrs. s via ORAL
7. SALBUTAMOL 3 puff c 6h
8. IPRATROPIO 3 puff c 6h
9. PREDNISONA 5 MG 1 cada 24 hrs.
10. CELECOXIB 200 MG 1 cada 24 hrs. SOS
11. METOTREXATO 2,5 MG 4 comprimidos a la semana en una sola toma
12. ACIDO FOLICO 5 MG 1 comp semanal
13. CALCIO 1125 MG / 175 MG 1 cada 24 hrs. via ORAL
14. SEGUIMIENTO POR FONOAUDIOLOGIA INTERDIARIO (Luego según criterio clínico)
15. SEGUIMIENTO POR KINESIOLOGÍA DIARIO (Luego según criterio clínico)
16. Control Poli medicina <30 dias
17. Control SOS

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO